

Anxiolyse en ESMS

Crise d'anxiété · anxiété durable · « si besoin » · arrêt — ce qui est recommandé, ce qui se fait, ce qu'il faut changer
Adulte et sujet âgé en EHPAD, USLD, MAS, FAM, EAM — repères pour les médecins DOTR



D'abord la cause

Douleur, fécalome, globe, infection, hypoxie, iatrogénie, sevrage, dépression : **chercher et traiter** avant tout anxiolytique.



Benzodiazépines : faible dose, courte durée

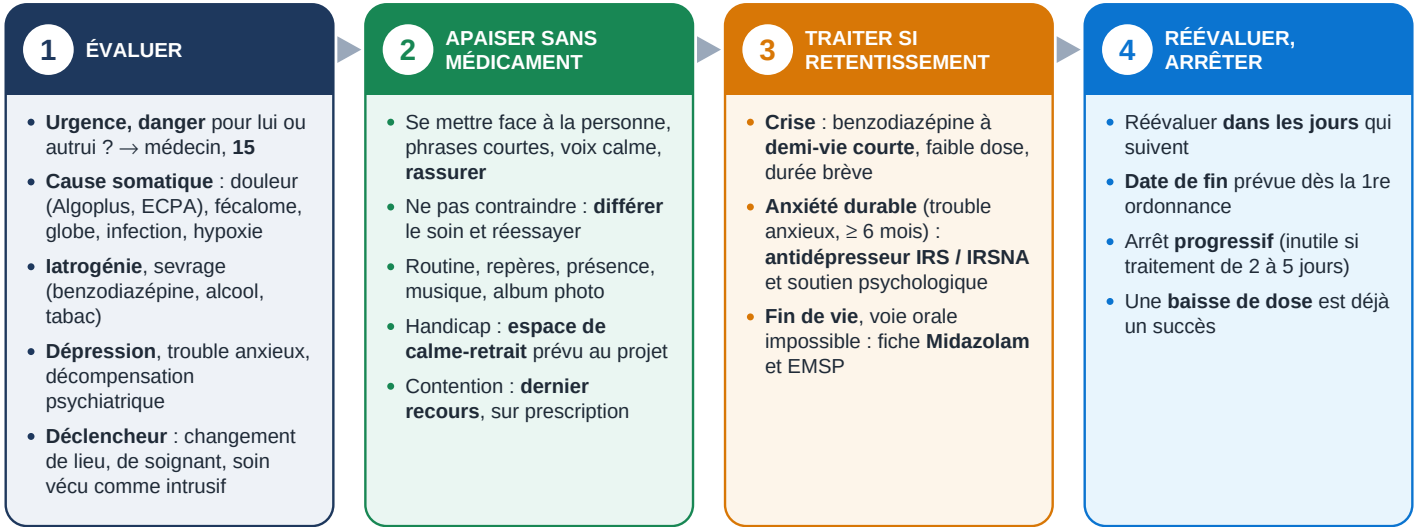
Dose minimale (½ dose chez le sujet âgé), **12 semaines maximum** décroissance comprise, **une seule** benzodiazépine.



Hydroxyzine : à éviter

Chez le sujet âgé : **non recommandée** (anticholinergique, allongement du QT) ; **50 mg/j maximum** si elle est utilisée.

La démarche en 4 temps



Sources : HAS, Alzheimer et apparentées : troubles du comportement perturbateurs (2009) · HAS-ANESM, Les comportements-problèmes (2016) · HAS, Quelle place pour les benzodiazépines dans l'anxiété ? (juil. 2024) · HAS, Arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés (2015) · REMEDI[e]S (Roux, Laroche et al., 2021)

Quelle molécule ? Chez le sujet âgé

Benzodiazépines anxiolytiques : liste I, 12 semaines maximum (Tranxène 20 mg : 4 semaines)

À privilégier	Crise d'anxiété du sujet âgé : benzodiazépine à demi-vie courte ou intermédiaire — oxazépam (Seresta) ≤ 30 mg/j , lorazépam (Témesta) ≤ 3 mg/j , alprazolam (Xanax) ≤ 2 mg/j = demi-dose de l'adulte ; débiter à la dose la plus faible
Anxiété durable	Trouble anxieux avéré ou anxiété depuis ≥ 6 mois : IRS / IRSNA ayant l'AMM — ex. escitalopram après 65 ans : 5 mg/j , puis 10 mg/j au maximum — et psychothérapie, soutien
À éviter	Demi-vie > 20 h : bromazépam (Lexomil), clorazépate (Tranxène), diazépam (Valium), prazépam (Lysanxia), loflazépate (Victan), nordazépam, clobazam · hydroxyzine (Atarax) · phénothiazines : cyamémazine (Tercian), alimémazine
Jamais	Deux benzodiazépines associées (anxiolytique + hypnotique compris) · reconduire sans réévaluer · benzodiazépine si apnées du sommeil, myasthénie, insuffisance respiratoire sévère

Sources : REMEDI[e]S (Roux, Laroche et al., 2021) · HAS, Quelle place pour les benzodiazépines dans l'anxiété ? (juil. 2024) · HAS, Alzheimer et apparentées : troubles du comportement perturbateurs (2009) · RCP (BDPM) : oxazépam, lorazépam, hydroxyzine, cyamémazine, escitalopram · EMA-PRAC, hydroxyzine (2015) · BDPM, conditions de prescription (sept. 2026)

À RETENIR

Une benzodiazépine soulage un symptôme, elle ne traite pas sa cause. Elle s'ajoute aux mesures non médicamenteuses, ne les remplace pas.

Repères pratiques : ne remplacent ni l'évaluation clinique, ni l'avis du psychiatre ou du gériatre, ni le protocole de l'établissement.

Proposition DOTR = choix d'organisation, non issu d'un texte.

PRESCRIRE « SI BESOIN » EN ESMS

Une prescription conditionnelle complète précise :

- le **résident** concerné (nominative)
 - la **situation déclenchante**, en signes **observables**
 - la molécule, la **dose**, la **voie**
 - l'**intervalle** minimal entre 2 prises
 - le **nombre maximal** de prises **par 24 h**
 - la **durée** (date de fin ou de réévaluation)
 - **quand appeler** le médecin
- Un « si besoin » **sans critère** ni maximum laisse la décision à l'équipe, **sans cadre**.

Sources : OMéDIT Centre-Val de Loire, prescription conditionnelle

QUI ADMINISTRE ?

IDE

- Sur prescription **écrite, qualitative et quantitative**, ou **protocole écrit daté et signé** par un médecin (CSP R4311-7)

Aide à la prise (AS, AES, éducateur)

- Possible si le mode de prise ne présente **ni difficulté d'administration ni apprentissage** particulier (CASF L313-26)

Proposition DOTR

- Un « si besoin » qui suppose d'**évaluer** le résident relève de l'**IDE**
- Sans IDE (nuit, FAM, MAS) : critères **simples et observables**, ou appel du médecin

Sources : CSP R4311-7 ; CASF L313-26

EXEMPLE DE RÉDACTION D'UN « SI BESOIN »

Proposition DOTR — à adapter au résident

Oxazépam 10 mg : 1 comprimé par voie orale **si** anxiété avec agitation (déambulation anxieuse, cris, appels répétés) **persistant malgré la réassurance**, après avoir vérifié l'absence de douleur, de globe, de fécalome. **Au moins 6 h** entre 2 prises, **2 prises au maximum par 24 h**, **pendant 7 jours** (réévaluation le JJ/MM). **2 prises en 24 h** ou **inefficace** : appeler le médecin. **Tracer** l'heure, le motif, l'effet.

Molécule, dose, intervalle et durée sont des **exemples de forme** : l'intervalle et la durée ne sont pas fixés par un texte.

ARRÊTER UNE BENZODIAZÉPINE AU LONG COURS

- **Toujours l'envisager**, en parler avec le résident et l'équipe (et la famille)
- **Progressif** : par exemple **5 à 10 %** de la dose toutes les **1 à 2 semaines**, ou **1/8** de la dose toutes les **2 semaines** ; paliers plus petits aux faibles doses
- Durée : **4 à 10 semaines** le plus souvent, jusqu'à **6 mois** ou plus après un échec
- Étape difficile : **garder le palier** quelques semaines plutôt que remonter
- Surveiller : **rebond** d'anxiété, insomnie, confusion
- Une **réduction** de dose est déjà un résultat favorable

Sources : HAS, Arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés (2015) · HAS, Quelle place pour les benzodiazépines dans l'anxiété ? (juil. 2024)

CE QUE DIT LA RÉGLEMENTATION

- Benzodiazépines anxiolytiques : **12 semaines** maximum par ordonnance ; hypnotiques : **4 semaines**
- **Tranxène 20 mg** : **4 semaines**, ordonnance sécurisée, en toutes lettres, chevauchement interdit
- **Hydroxyzine** : 100 mg/j maximum chez l'adulte, **50 mg/j** chez le sujet âgé ; contre-indiquée si **QT long** ou facteur de risque
- **Cyamémazine** dans l'anxiété : **après échec** des traitements habituels, **4 semaines** maximum (RCP)
- Détail par spécialité : onglet **Médicament express** de l'Espace VMS/DOTR

Sources : Arrêté du 07/10/1991 ; CSP R5132-21 · BDPM, conditions de prescription (sept. 2026) · RCP (BDPM) : oxazépam, lorazépam, hydroxyzine, cyamémazine, escitalopram · EMA-PRAC, hydroxyzine (2015)

VU SUR LE TERRAIN

« **Atarax si agité** » chez une personne âgée → déconseillé (anticholinergique, QT) : chercher la cause, puis oxazépam faible dose si besoin. « **Tercian gouttes le soir** » depuis des mois → phénothiazine anticholinergique, AMM anxiété limitée à 4 semaines : réévaluer. « **Lexomil le matin, Témesta le soir** » → deux benzodiazépines : n'en garder qu'une, puis décroître. « **Renouvelé depuis l'entrée** » → réévaluer à chaque renouvellement, programmer l'arrêt.

Sources : REMEDI[e]S (Roux, Laroche et al., 2021) · HAS, Alzheimer et apparentés : troubles du comportement perturbateurs (2009) · RCP (BDPM) : oxazépam, lorazépam, hydroxyzine, cyamémazine, escitalopram

Sources : HAS, Quelle place pour les benzodiazépines dans l'anxiété ? (fiche BUM, juillet 2024) ; HAS, Arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés : démarche du médecin traitant (2015) ; HAS, Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement perturbateurs (2009) ; HAS-ANESM, Les « comportements-problèmes » (2016) ; HAS, Pratiques sédatives — fiche MG (2020) ; REMEDI[e]S, Roux et al., Eur J Clin Pharmacol 2021 (critères B/R-10, B/R-35, DO-4, DU-1, D-7) ; RCP (BDPM) Seresta, Lorazépam Viartis, Atarax, Tercian, Escitalopram ; EMA-PRAC, hydroxyzine (2015) ; BDPM, conditions de prescription et de délivrance (28/09/2026) ; arrêté du 07/10/1991 ; CSP R5132-21, R4311-7 ; CASF L313-26 ; OMéDIT Centre-Val de Loire, prescription conditionnelle. Clotiazépam (cité par REMEDI[e]S) et méprobamate (cité par la HAS en 2009) : absents de la BDPM. Non trouvé dans ces sources : un intervalle minimal entre deux prises « si besoin » fixé par un texte.

Repères pratiques : ne remplacent ni l'évaluation clinique, ni l'avis du psychiatre ou du gériatre, ni le protocole de l'établissement.

Proposition DOTR = choix d'organisation, non issu d'un texte.